

«Шигельоз»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- вияснити анамнез захворювання (у т.ч. епідеміологічний) анамнез та анамнез життя;
- продемонструвати практичну навичку “Поверхнева пальпація живота”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових досліджень:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження хворого з діагнозом «Шигельоз».

• Додаток 1. Об’єктивне обстеження пацієнта

Стан середньої тяжкості. Зріст 172 см, вага 69 кг. Шкіра гіперемована, суха, гаряча на дотик, висипка відсутня. ЧДР 20 за хв. Тони серця приглушені, ритмічні. ЧСС=Пс=106 за хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. У легенях – везикулярне дихання. Печінка та селезінка не збільшені не пальпуються. Випорожнення 20 разів на добу, з домішками крові та слизу, сечовипускання без особливостей.

• Додаток 2. Заключення поверхневої пальпації живота (видається після демонстрації навички)

Живіт м’який, болісний у лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована. Ознаки подразнення очеревини негативні.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви – лікар приймального відділення. До Вас звернувся чоловік.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.

<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович.	Дуже приємно.
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Іван Петрович
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	42 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Водієм
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»	Наша розмова конфіденційна, можете мені довіритися.	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Іване Петровичу, що Вас турбує?	У мене підвищення температури тіла до 39,2°C, пронос, біль в животі, сухість у роті, слабкість.
	Скажіть будь ласка скільки раз на добу у Вас випорожнення.	До 20 разів.
	Випорожнення рідкі чи кашцеподібні? Домішки крові, слизу, гною є?	Випорожнення рідкі, як вода. Так, з домішками слизу та крові.
	В якій ділянці болює живіт?	Живіт почав боліти спочатку зверху, а потім біль опустився донизу. От тут, внизу живота зліва. Біль посилюється під час дефекації.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Коли Ви захворіли?	Вчора.
	Розкажіть будь ласка з чого все почалося?	В мене раптово підвищилася температура тіла до 39,6°C, з'явилося блювання 2 рази, потім почав боліти живіт і з'явилися рідкі випорожнення.

	Ви щось приймали?	Самостійно приймав парацетамол, активоване вугілля.
	Вам стало краще після прийому ліків?	Ні, сьогодні зранку помітив слиз та кров у випорожненнях і поїхав у лікарню.
<i>Запитати епідеміологічний анамнез:</i>	Іване Петровичу, що Ви їли напередодні захворювання?	Були у кума в гостях, він пригощав домашнім сиром зі сметаною.
	Були випадки подібних захворювань серед близьких та знайомих?	У кума теж пронос і блювота.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, ангіною в дитинстві.
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?	Ні
	Операції, травми протягом життя?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Шкідливі звички?	Палив 10 років. Потім кинув.
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Іване Петровичу, зараз я Вам проведу поверхневу пальпацію живота, будь ласка зніміть одяг.	Так, гаразд.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		
<i>Провести поверхневу пальпацію живота</i>	Коректне проведення поверхневої орієнтовної пальпації (лікар свою долоню кладе пласко на живіт пацієнта і проводить легкі, обережні натискання м'якушем нігтьових фаланг пальців, перемішуючи	

	на 3-4 см в боки послідовно (проти часової стрілки): ліва здухвинна ділянка, ліва бокова ділянка, ліве підребер'я, епігастральна ділянка, праве підребер'я, права бокова ділянка, права здухвинна ділянка, навколупупкова ділянка, надлобкова ділянка	
	Дослідження білої лінії живота (просять пацієнта, який перебуває в горизонтальному положенні, підняти голову, відірвавши її від подушки без допомоги рук, а лікар у цей час проводить своїм вказівним пальцем по середній лінії живота нижче мечоподібного відростка)	
	Оцінка напруження, резистентності, болючості передньої черевної стінки, розходження прямих м'язів живота. Наявність вільної рідини.	Видати здобувачу освіти додаток 2 в паперовому вигляді.
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Уточнити самопочуття</i>	Як Ви себе почуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так. Добре.
<i>Пояснити подальші дії</i>	Іване Петровичу, у Вас гостра кишкова інфекція, раджу Вам подальше дообстеження в інфекційному стаціонарі для встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	Зрозуміла.
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром –гострий гастроентероколіт	
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Перед початком роботи з харчовими продуктами слід ретельно мити руки. Забруднений одяг, простирадла	Дякую, лікарю.

	та ковдри слід замочувати у закритій посудини з милом, водою та дезінфікуючим засобом, доки їх не можна буде випрати в гарячій воді. Відновлення втраченої рідини та електролітів оральним регідратаційним розчином	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Іване Петровичу, Вам все зрозуміло?	Все зрозумів
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.